



# 疟疾

2025年12月4日 | 阅读时间 13 分钟 (3413 字)

[English](#)

[العربية](#)

[Français](#)

[Русский](#)

[Español](#)

## 重要事实

- 2024年，全球80个国家估计有2.82亿例疟疾病例和61万例疟疾死亡。
- 世卫组织非洲区域在全球疟疾负担中所占比例畸高。
- 2024年，世卫组织非洲区域占疟疾病例数的95%（2.65亿例）和疟疾死亡人数的95%（57.9万例）。
- 五岁以下儿童占该区域疟疾总死亡人数的大约75%。

## 概述

疟疾是一种通过某些类型的蚊子传播给人类的疾病，可危及生命。它主要分布在热带国家。疟疾可防可治。

感染由寄生虫引起，且不会在人与人之间传播。

症状可能轻微，也可能危及生命。轻微症状是发热、寒战和头痛。严重症状包括疲劳、意识模糊、癫痫发作和呼吸困难。

婴儿、五岁以下儿童、孕妇和女童、旅行者和艾滋病毒感染者或艾滋病患者发生严重感染的风险更高。

疟疾可以通过避免蚊虫叮咬和服用药物来预防。治疗可以阻止轻症恶化。

疟疾主要通过一些受感染的雌性按蚊的叮咬传播给人。输血和受污染的针头也可能传播疟疾。最初的症状可能比较轻微，类似于许多发热性疾病，并且难以识别为疟疾。如不加以治疗，恶性疟原虫疟疾可能在24小时内发展成严重疾病，甚至死亡。

共有五种寄生虫会导致人类疟疾，其中恶性疟原虫和间日疟原虫危害最大。恶性疟原虫是最致命的疟疾寄生虫，在非洲大陆上最流行。间日疟原虫是撒哈拉以南非洲之外大部分国家的主要疟疾寄生虫。其他可以感染人类的疟疾病种是三日疟原虫、卵形疟原虫和诺氏疟原虫。

# 症状

疟疾最常见的早期症状是发热、头痛和寒战。

症状通常在被受感染的蚊子叮咬后10-15天内开始。

有些人的症状可能很轻微，特别是那些以前感染过疟疾的人。由于一些疟疾症状不具有特异性，因此尽早接受检测很重要。

某些类型的疟疾可导致重症和死亡。婴儿、五岁以下儿童、孕妇、旅行者和艾滋病毒感染者或艾滋病患者的风险更高。严重症状包括：

- 极度疲劳和倦怠
- 意识障碍
- 多次抽搐
- 呼吸困难
- 尿色深或带血
- 黄疸（眼睛和皮肤发黄）
- 异常出血。

出现重症者应立即接受紧急护理。早期治疗轻症可以阻止感染变得严重。

怀孕期间感染疟疾可能导致早产或生产低出生体重婴儿。

# 疾病负担

根据最新的《世界疟疾报告》，2024年发生2.82亿例疟疾病例，比2023年增加约900万例（3%）。2024年的疟疾死亡人数估计为61万人，而2023年为59.8人。

世卫组织非洲区域在全球疟疾负担中所占比例仍然过高。2024年，该区域占疟疾病例和死亡总数的95%。该区域半数以上的死亡发生在三个国家：尼日利亚（31.9%）、刚果民主共和国（11.7%）、尼日尔（6.1%）。五岁以下儿童占该区域疟疾总死亡人数的大约75%。

# 预防

可以通过避免蚊虫叮咬和服用药物预防疟疾。在前往疟疾常见地区之前，请与医生讨论服用化学预防药物。

通过避免蚊虫叮咬降低患疟疾的风险：

- 在有疟疾的地方睡觉时使用蚊帐。
- 黄昏后使用驱蚊剂(含避蚊胺、驱蚊酯或埃卡瑞丁)。
- 使用蚊香和电热驱蚊液。
- 穿防护服装。
- 使用纱窗。

## 病媒控制

病媒控制是疟疾控制和消除战略的重要组成部分，因为病媒控制对预防感染和减少疾病传播非常有效。两个核心干预措施是药浸蚊帐和室内滞留喷洒。

全球疟疾控制进展受到按蚊对杀虫剂出现耐药性的威胁。然而，越来越普及的新一代蚊帐比只使用拟除虫菊酯的蚊帐能够更好地预防疟疾，这种蚊帐是全球抗击疟疾努力的重要工具。

斯氏按蚊给非洲疟疾控制带来了额外的挑战。这种入侵的蚊子最初原产于南亚和阿拉伯半岛的部分地区，过去十年来其活动范围不断扩大，据报道，迄今为止已在八个非洲国家发现。斯氏按蚊在城市环境中繁衍生息，能够耐受高温，并对许多用于公共卫生的杀虫剂具有耐药性。

## 化学预防

前往疟疾流行地区的旅行者应在出发前几周咨询医生。医疗专业人员将确定哪种化学预防药物适合目的地国家。在某些情况下，化学预防药物必须在出发前2-3周开始使用。在疟疾风险地区住院期间，应按时服用所有预防性药物，并在最后一次可能接触感染后持续服用4周，因为在此期间寄生虫仍可能从肝脏中出现。

## 预防性化疗

预防性化疗是单独或联合使用药物来预防疟疾感染及其后果。它要求在疟疾风险最大阶段的指定时间点向弱势人群提供完整的抗疟疗程，无论接受治疗者是否感染疟疾。

预防性化疗包括常年性疟疾化学预防(PMC)、季节性疟疾化学预防(SMC)、针对孕妇(IPTp)和学龄儿童(IPTsc)的间歇性预防性治疗、出院后化学预防(PDMC)和大型服药活动(MDA)。这些安全和具有成本效益的策略旨在补充正在进行的疟疾控制活动，包括病媒控制措施、疑似疟疾的及时诊断以及用抗疟药物治疗确诊病例。

## 疫苗

自2021年10月以来，世卫组织建议生活在恶性疟原虫中度至高度传播地区的儿童广泛使用RTS,S/AS01疟疾疫苗。该疫苗已被证明能显著减少幼儿中的疟疾病例和致命的严重疟疾。2023年10月，世卫组织建议使用第二种安全有效的疟疾疫苗R21/Matrix-M。目前正在非洲各地的常规儿

童免疫接种规划中推广疫苗。非洲的疟疾疫苗预计每年将拯救数以万计的年轻生命。然而，当疫苗与世卫组织推荐的其他疟疾干预措施（如蚊帐和化学预防）结合使用时，将会取得最大效果。

## 疟疾疫苗问答

# 治疗

疟疾的早期诊断和治疗可以减少疾病，防止死亡，并有助于减少传播。世卫组织建议使用基于寄生虫的诊断检测（通过显微镜或快速诊断检测）来确认所有疑似疟疾病例。

疟疾是一种严重感染，总是需要药物治疗。

现有多种用来预防和治疗疟疾的药物。医生将根据以下因素选择其中一种或多种：

- 疟疾类型
- 疟疾寄生虫是否对药物耐药
- 疟疾感染者的体重或年龄
- 患者是否怀孕。

这些是最常见的抗疟药：

- 青蒿素为基础的联合治疗药物通常是治疗恶性疟原虫疟疾最为有效的方法。
- 氯喹被推荐用于治疗间日疟原虫感染，仅在这种疟原虫对这种药物仍然敏感的地方。
- 伯氨喹应添加到主要治疗中，以防止间日疟原虫和卵形疟原虫感染复发。

使用的大多数药物为片剂。有些人可能需要去卫生保健中心或医院注射药物。

## 抗疟药耐药性

在大湄公河次区域出现部分青蒿素耐药性之后，世卫组织十分关注厄立特里亚、卢旺达、乌干达和坦桑尼亚联合共和国确认出现的部分青蒿素耐药性情况。根据现有证据，在埃塞俄比亚、纳米比亚、苏丹和赞比亚也怀疑存在这种耐药性。

2022年，世卫组织制定了遏制非洲抗疟药耐药性战略。需要定期监测抗疟药疗效，为疟疾流行国的治疗政策提供信息，并确保及早发现和应对耐药性。

如需了解更多世卫组织在大湄公河次区域抗疟药耐药性方面的工作，请访问[湄公河消除疟疾规划网页](#)。

# 基因突变

大多数疟疾快速诊断检测（RDTs）针对的是恶性疟原虫产生的一种或两种特定蛋白质：HRP2和HRP3。然而，这些检测法无法检测到具有基因突变的寄生虫，基因突变会阻止上述蛋白质的表达。这意味着疟疾患者可能无法被诊断出来，从而让这些突变的寄生虫得以传播。2024年，这些突变寄生虫在42个疟疾流行国家报告出现；越南在2024年首次作出报告。尽管突变寄生虫的估计流行率在大多数国家仍然较低，但在巴西、吉布提、厄立特里亚、埃塞俄比亚、尼加拉瓜和秘鲁已超过15%。

## 消除

消除疟疾的定义是，在规定的地理区域内，有意识地开展活动，中断特定疟疾寄生虫物种的当地传播。需要继续采取措施防止传播再度发生。

2024年，37个国家报告本地病例不到1000例，高于2000年时仅有的13个国家。至少连续三年本地疟疾病例为零的国家有资格申请[世卫组织消除疟疾认证](#)。自2015年以来，17个国家经世卫组织总干事认证为无疟疾，它们是：马尔代夫（2015年）、斯里兰卡（2016年）、吉尔吉斯斯坦（2016年）、巴拉圭（2018年）、乌兹别克斯坦（2018年）、阿根廷（2019年）、阿尔及利亚（2019年）、中国（2021年）、萨尔瓦多（2021年）、阿塞拜疆（2023年）、塔吉克斯坦（2023年）、伯利兹（2023年）、佛得角（2024年）、埃及（2024年）、格鲁吉亚（2025年）、苏里南（2025年）和东帝汶（2025年）。

[世卫组织认证为无疟疾的国家和领地。](#)

## 监测

[疟疾监测](#)涉及持续、系统地收集、分析和解释疟疾相关数据，并使用这些数据规划、实施和评估公共卫生做法。疟疾病例和死亡监测的改善有助于卫生部确定哪些地区或人群受影响最大，并使各国能够监测不断变化的疾病模式。强大的疟疾监测系统也有助于各国设计有效的卫生干预措施，并评估其疟疾控制规划的影响。

## 世卫组织的应对

2021年更新的世卫组织[《2016-2030年全球疟疾技术战略》](#)为所有疟疾流行国家提供了一个技术框架。该框架用于指导和支持控制和消除疟疾的区域和国家规划。

这项战略确定了宏伟但切实可行的全球目标，包括：

- 到2030年将疟疾病例发病率至少降低90%
- 到2030年将疟疾死亡率至少降低90%
- 到2030年至少在35个国家消除疟疾

- 在所有已无疟疾传播国家中防止再次出现疟疾。

全球疟疾规划负责在该战略指导下协调世卫组织在全球范围内控制和消除疟疾的工作，具体办法是：

- 在疟疾方面发挥领导作用，有效支持会员国和团结伙伴实现全民健康覆盖，实现《全球疟疾技术战略》的目标和具体目标；
- 制定研究议程并促进证据的产生，以支持为新工具和策略提供全球指导，以产生影响；
- 制定基于伦理和循证的全球抗疟指导文件，并有效传播，以支持国家疟疾规划和其他相关利益攸关方的通过和实施；
- 监测和应对全球疟疾趋势和威胁。